
Farmacologia para Odontologia

Farmacologia para Odontologia

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 1

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Introdução à Farmacologia	3
02 Farmacocinética	5
03 Farmacodinâmica	6
04 Neurotransmissores e Psicofármacos	7
05 Analgésicos	8
06 Anti-inflamatórios	9
07 Sistema Cardiovascular	10
08 Anestesia Local	11
09 Antibióticos	12
10 Aplicação nas Especialidades	13
11 Referências	15

01

FARMACOLOGIA PARA ODONTOLOGIA

Introdução à Farmacologia

Conceitos Básicos

PONTOS-CHAVE

Farmacologia: ciência que estuda os fármacos e seus efeitos no organismo.

Fármaco: é o princípio ativo com potencial terapêutico.

Medicamento: contém o(s) fármaco(s) dentro de uma formulação.

Droga: termo reservado a substâncias com potencial de abuso ou uso recreativo.

(American Society of Anesthesiologists): Avaliação do estado geral do paciente para cálculo do risco cirúrgico:

ASA+ I: Paciente saudável.

ASA II: Doenças sistêmicas leves (ex.: hipertensão controlada, diabetes tipo 2 controlado, gestação inicial).

ASA III: Doenças sistêmicas moderadas/gravas (ex.: diabetes tipo 1, hipertensão não controlada).

ASA IV: Doenças graves com risco de vida.

ASA V: Pacientes críticos dependentes de cirurgia para sobreviver.

ASA VI: Pacientes com morte cerebral.

Escala de Dor

Vias de Administração de Fármacos

Via Enteral: Oral, sublingual e retal.

Via Parenteral: Intravenosa, intramuscular, subcutânea, intra-articular, intradérmica, entre outras.

Via Tópica: Cutânea, mucosa, oftálmica, vaginal.

Prescrição Medicamentosa

Tipos de Receituário:

Tipo A (amarelo): Entorpecentes.

Tipo B (azul): Benzodiazepínicos.

Controle especial: Medicamentos controlados.

Receituário comum (branco): Medicamentos não controlados.

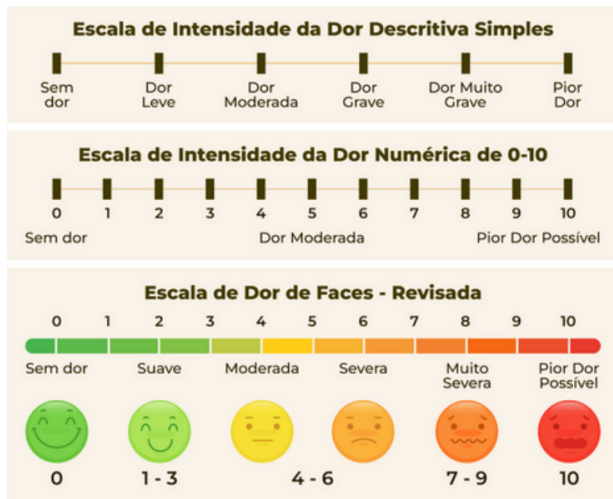
Formas Farmacêuticas

Sólidas: Comprimidos, drágeas, cápsulas.

Semissólidas: Pomadas.

Líquidas: Soluções, suspensões, emulsões.

Gasosas: Aerossóis.



Classificação ASA

RECEITA BRANCA

C1, C2, C3
C4, C5

RECEITA AZUL

B1 e B2

RECEITA AMARELA

A1, A2, 3

Receita Branca

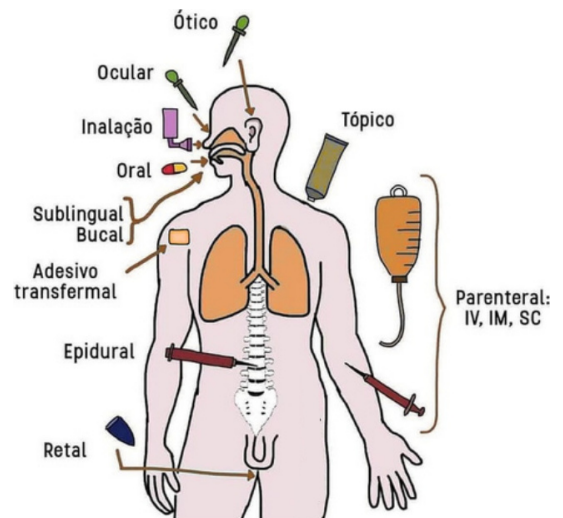
Antibióticos, anticonvulsivante não barbitúrico e não sedativo, antidepressivo, antiparkinsoniano.

Receita Azul

Drogas psicotrópicas, drogas inibidoras do apetite, sedativos, diazepínicos e barbitúricos.

Receita Amarela

Opióides e anfetaminas impressas e fornecidas aos médicos pela vigilância sanitária.



ANOTAÇÕES

02

FARMACOLOGIA PARA ODONTOLOGIA

Farmacocinética

Etapas

PONTOS-CHAVE

Absorção: entrada do fármaco no organismo.

Distribuição: transporte pelo sangue até os tecidos.

Metabolização (biotransformação): transformação química, principalmente no fígado.

Excreção: eliminação do fármaco via urina, fezes, suor, saliva etc.

Conceitos Importantes

Biodisponibilidade: fração do fármaco que chega à circulação sistêmica.

Índice terapêutico: dose ideal para eficácia sem toxicidade.

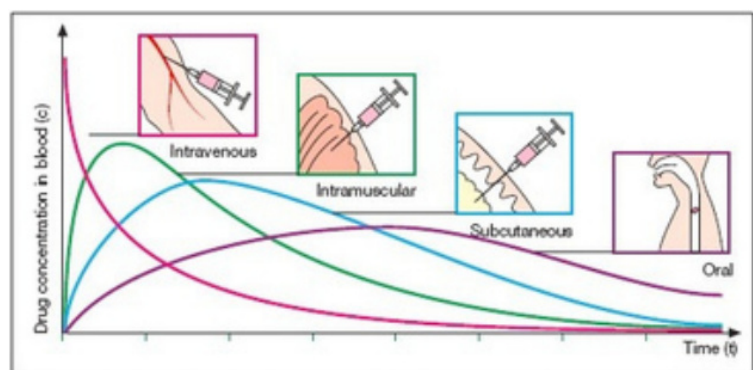
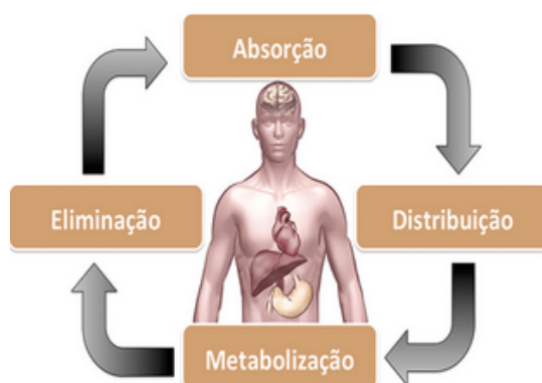
Volume de distribuição: relação entre concentração nos tecidos e no sangue.

Influência na absorção

Via de administração, doenças, idade, sexo, etnia, peso, solubilidade do fármaco, tamanho molecular e grau de ionização.

Lipossolúveis: absorvidos com alimentos.

Hidrossolúveis: ideal tomar longe das refeições.



ANOTAÇÕES

03

FARMACOLOGIA PARA ODONTOLOGIA

Farmacodinâmica

Etapas

PONTOS-CHAVE

Biofase: local onde o fármaco encontra seu receptor.

Ação: ligação fármaco-receptor.

Efeito: resposta clínica (analgesia, sedação, anti-inflamatório, etc).

Tipos de fármacos

Agonistas: imitam o efeito natural (ex: adrenalina).

Antagonistas: bloqueiam os receptores (ex: atenolol).

Agonistas parciais: ativam parcialmente.

Tipos de receptores

Inotrópicos (canais iônicos): abrem ou fecham canais iônicos (ação em milissegundos).

Acoplados à proteína G:

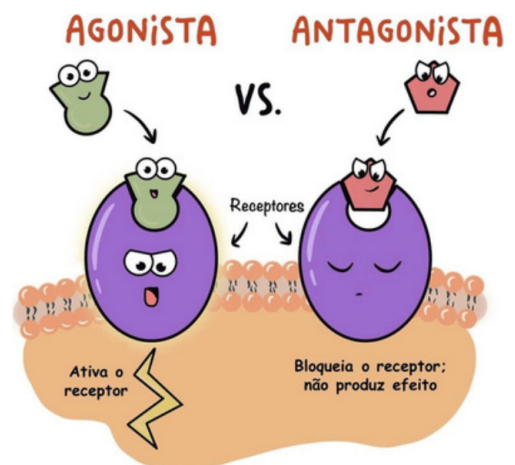
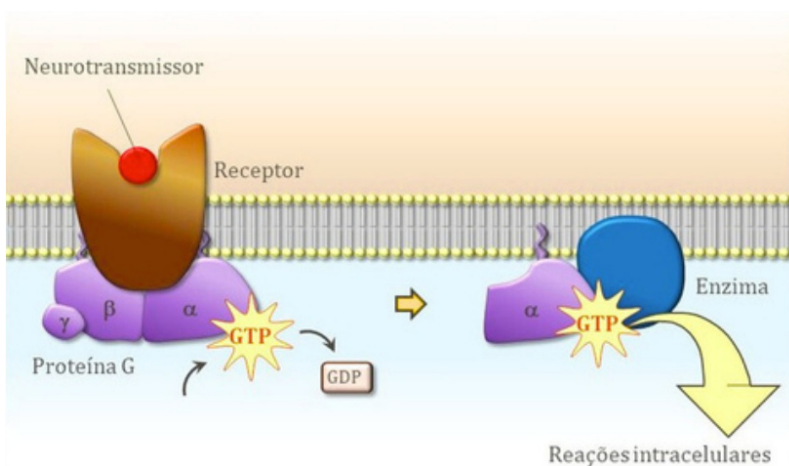
Gs: estímulo direto

Gi: inibição

Gq: ativação indireta via quinase

Enzimáticos intracelulares: como os ativados pela insulina.

Nucleares: agem no DNA celular (ex: corticoides).



ANOTAÇÕES

04

FARMACOLOGIA PARA ODONTOLOGIA

Neurotransmissores e Psicofármacos

Principais neurotransmissores

PONTOS-CHAVE

Noradrenalina (NE): excitatório, regula humor, atenção e dor.

Serotonina (5HT): humor, apetite, sono, libido.

Dopamina (DA): prazer, recompensa, controle motor.

GABA: inibitório, promove relaxamento.

Fármacos ansiolíticos e antidepressivos

Tricíclicos: amitriptilina, imipramina – causam xerostomia.

ISRS: fluoxetina, sertralina – afetam libido e sono.

IMAO: fenelzina, selegilina – inibem enzima que destrói neurotransmissores.

Benzodiazepínicos: agem via GABA – sedativos, relaxantes.

Simpático (luta/fuga)

Receptores adrenérgicos:

α_1 : vasoconstrição

α_2 : inibe insulina e liberação de NE

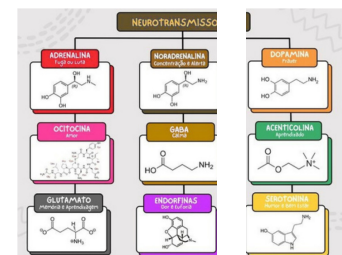
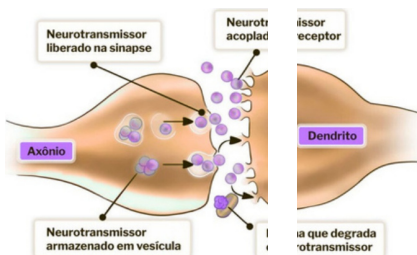
β_1 : coração – aumenta FC e força

β_2 : relaxa musculatura lisa (brônquios)

Fármacos relacionados:

Adrenalina: usada com anestésicos para vasoconstrição.

Propranolol: antagonista β – trata hipertensão e arritmia.



ANOTAÇÕES

05

FARMACOLOGIA PARA ODONTOLOGIA

Analgésicos

Opioides (fortes):

PONTOS-CHAVE

Morfina, codeína, fentanil: atuam na medula espinal, bloqueiam dor.

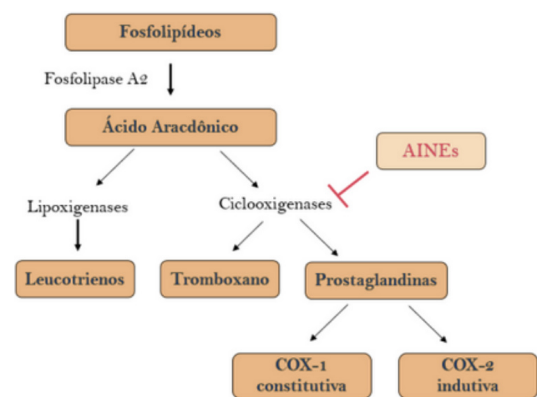
Efeitos adversos: depressão respiratória, constipação, miose.

Não-opioides:

Paracetamol e dipirona: agem no hipotálamo, antitérmicos e leves analgésicos.

Paracetamol: Analgésico seguro em gestantes.

AINEs (anti-inflamatórios não esteroidais): inibem COX 1 e 2 (ex: ibuprofeno, nimesulida).



ANOTAÇÕES

06

FARMACOLOGIA PARA ODONTOLOGIA

Anti-inflamatórios

Objetivos

PONTOS-CHAVE

Eliminar o agente agressor.

Promover regeneração.

Enzimas

COX-1: funções fisiológicas (protege estômago, plaquetas).

COX-2: inflamatória.

COX-3: atua no SNC (paracetamol).

Fosfolipase A2: inibida pelos esteroidais (AIEs).

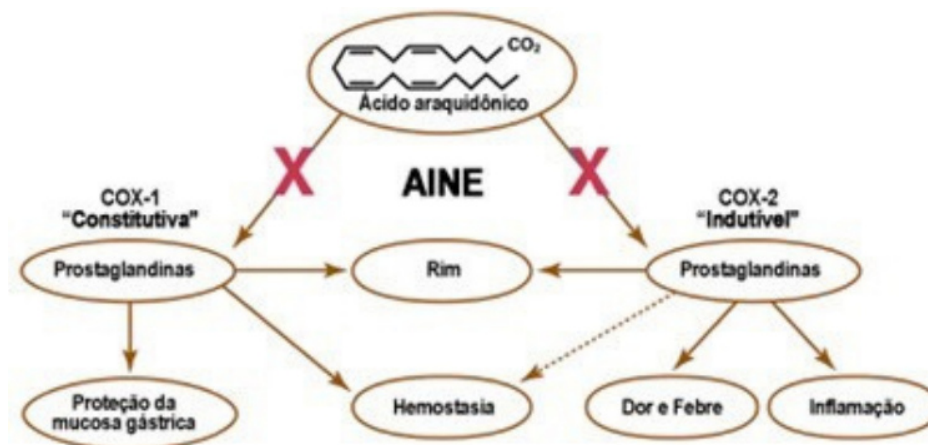
Tipos:

AINEs não seletivos: ibuprofeno, aspirina.

AINEs seletivos COX-2: celecoxibe.

Corticoides (AIEs): prednisona – ação anti-inflamatória e imunossupressora.

Efeitos adversos: candidíase, osteoporose, hiperglicemia.



ANOTAÇÕES

07

FARMACOLOGIA PARA ODONTOLOGIA

Sistema Cardiovascular

Receptores

PONTOS-CHAVE

Simpático: α e β – aumenta PA e FC.

Fármacos

Digoxina: aumenta cálcio no miocárdio – usada em insuficiência cardíaca.

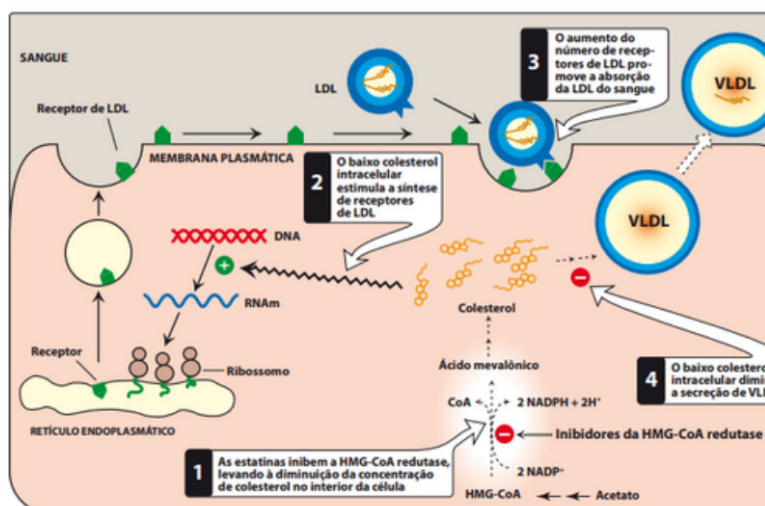
Diuréticos: reduzem volume sanguíneo → menor PA.

Betabloqueadores: propranolol, atenolol – controlam PA e FC.

IECA/BRA: inibem ação da angiotensina – diminuem pressão.

Anlodipino: bloqueia cálcio – anti-hipertensivo.

Estatinas: reduzem colesterol – previnem trombooses.



ANOTAÇÕES

08

FARMACOLOGIA PARA ODONTOLOGIA

Anestesia Local

Objetivo

PONTOS-CHAVE

Bloquear condução do impulso nervoso (dor).

Composição

Porção apolar (ativa – atravessa membrana).

Porção polar (amina – solubilidade).

Cadeia intermediária:

Éster: mais tóxico, biotransformação no sangue.

Amida: menos tóxico, metabolizado no fígado.

Com ou sem vasoconstritor:

Com vaso (ex: adrenalina): prolonga efeito e reduz sangramento.

Sem vaso: meia-vida curta, indicado em casos específicos.

Felipressina: vaso não adrenérgico – alternativa segura.

Antissépticos Odontológicos

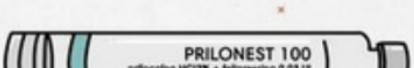
Bloquear condução do impulso nervoso (dor).

Iodopovidona 10%: Antissepsia pré-operatória.

Clorexidina:

Digluconato 0,12% (bochechos).

Gel 2% (uso intracanal).

	ALPHACAINE 100 lidocaína HCl 2% + epinefrina 1:100.000 36mg + 18ug / cartucho	LIDOCAÍNA dose máx recomendada: 7.0mg/kg metabolismo: fígado potência: 2 início de ação: 2 à 4 min
	ARTICAINE 100 articaina + epinefrina 1:100.000 72mg + 18ug / cartucho	ARTICAÍNA dose máx recomendada: 6.6mg/kg metabolismo: plasma e fígado potência: 1.9 início de ação: 1 à 3 min
	MEPIADRE 100 mepivacaína HCl 2% + epinefrina 1:100.000 36mg + 18 ug / cartucho	MEPIVACAÍNA dose máx recomendada: 6.6mg/kg metabolismo: fígado potência: 2 início de ação: 1,5 à 2 min
	MEPIV 3% mepivacaína HCl 3% sem vasoconstritor 54mg / cartucho	MEPIVACAÍNA dose máx recomendada: 2.0mg/kg metabolismo: fígado potência: 4 início de ação: 6 à 10 min
	PRILONEST 100 prilocaína HCl 3% + felipressina 0,03 1% 54mg + 0,05403 / cartucho	PRILOCAÍNA dose máx recomendada: 8.0mg/kg metabolismo: fígado e pulmão potência: 2 início de ação: 2 à 4 min

ANOTAÇÕES

09

FARMACOLOGIA PARA ODONTOLOGIA

Antibióticos

Classificação

PONTOS-CHAVE

Bactericidas: matam a bactéria.

Bacteriostáticos: impedem a multiplicação.

Betalactâmicos: Penicilinas (G, V, amoxicilina) e cefalosporinas.

Macrolídeos: Eritromicina, azitromicina.

Lincosamidas: Clindamicina.

Tetraciclínas: Contraindicadas na gravidez e infância.

Metronidazol: Eficaz contra anaeróbios.

Composição

Amoxicilina: amplo espectro – indicada empiricamente.

Espectro:

Amplo: age em muitos tipos.

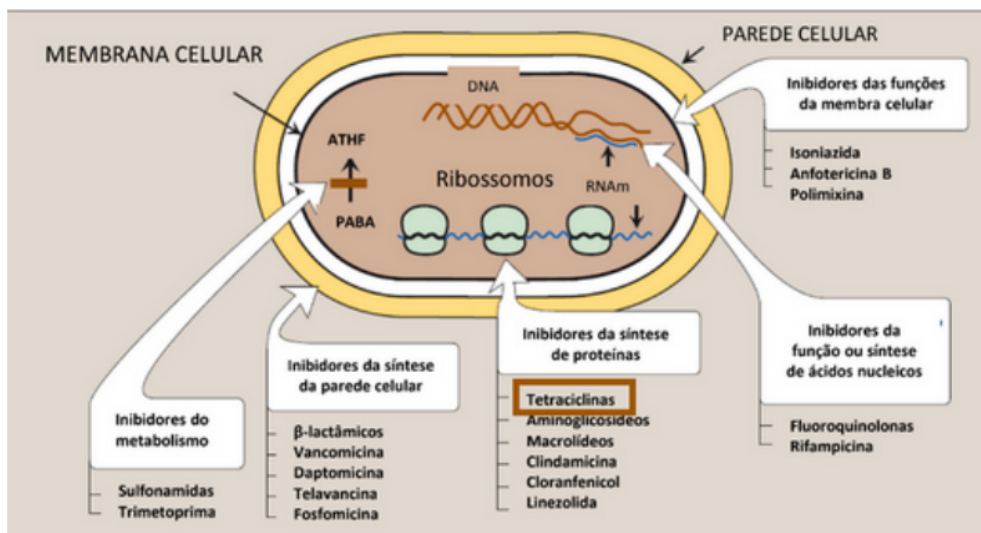
Estreito: específico.

Estendido: eficaz em um grupo, fraco em outro.

Uso consciente é importante

Uso prolongado → candidíase oral/genital.

Sempre respeitar tempo e dose da prescrição.



ANOTAÇÕES

10

FARMACOLOGIA PARA ODONTOLOGIA

Aplicação nas Especialidades

Endodontia

Irrigantes e Medicamentos:

PONTOS-CHAVE

Hipoclorito de sódio.
EDTA.
Clorexidina.
Paramonoclorofenol canforado.
Formocresol.
Hidróxido de cálcio.

Cirurgia

Pré-operatório:

Ansiolíticos (benzodiazepínicos), corticosteroides, AINEs.

Transoperatório:

Anestésicos locais.

Profilaxia Antibiótica:

Amoxicilina, clindamicina, azitromicina, cefalexina.

Estomatologia

Medicações para lesões orais:

Aciclovir (herpes).
Nistatina (candidíase).
Omcilon-A (lesões ulcerativas).
Hexomedine (spray antiviral).

Farmacologia em Gestantes

Atendimento ideal: 2º trimestre.

Anestésicos seguros: Lidocaína 2% (preferencial).

Analgesia: Paracetamol.

Antiinflamatórios: Corticoides em dose única.

Cuidados com posição na cadeira odontológica.



ANOTAÇÕES

11

FARMACOLOGIA PARA ODONTOLOGIA

Referências

ANDRADE, E. D. Terapêutica Medicamentosa em Odontologia. 3ª ed. Artes Médicas, 2013.

ANOTAÇÕES

Guia Prático Farmacologia

Farmacologia na odontologia

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 2

Produção: OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Analgésicos, Anti-inflamatórios e Antibióticos	3
02 Antifúngicos, Antivirais, Relaxantes, Ansiolíticos e Antialérgico	4
03 Terapia Complementar	5
04 Situações Clínicas	6
05 Fármacos Mais Utilizados	7
06 Atenção!	8

01

FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA

Analgésicos, Anti-inflamatórios e Antibióticos

1. Analgésicos e Antitérmicos

Para dor leve a moderada e febre

PONTOS-CHAVE

Dipirona – 1 g VO 6/6h, até 3 dias.

Paracetamol – 750 mg VO 6/6h ou 1 g VO 8/8h, máximo 4 g/dia.

Ibuprofeno – 400 mg VO 6/6h, até 5 dias.

2. Anti-inflamatório

Controle de inflamação e edema

Nimesulida – 100 mg VO 12/12h, 3–5 dias.

Dexametasona – 4 mg VO 12/12h, 2–3 dias.

Prednisona – 20–40 mg VO ao dia, 3–5 dias.

3. Antibióticos

Infecções odontogênicas

Amoxicilina – 500 mg VO 8/8h, 7 dias.

Amoxicilina + Clavulanato – 875+125 mg VO 12/12h, 7 dias.

Azitromicina – 500 mg VO 1x/dia, 3 dias (alérgicos à penicilina).

Clindamicina – 300 mg VO 8/8h, 7 dias (infecções graves/alérgicos).

Metronidazol – 400 mg VO 8/8h, 7 dias (anaeróbios, em associação).

Cefalexina – 500 mg VO 6/6h, 7 dias (infecções de pele/celulite facial).

4. Profilaxia Antibiótica

Em risco de endocardite

Amoxicilina – 2 g VO, 1h antes do procedimento.

Clindamicina – 600 mg VO, 1h antes (alérgicos).

ANOTAÇÕES

02

FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA

Antifúngicos, Antivirais, Relaxantes, Ansiolíticos e Antialérgico

5. Antifúngicos

Candidíase oral

PONTOS-CHAVE

Fluconazol – 150 mg VO dose única ou 100 mg/dia por 7–14 dias.

Nistatina suspensão oral – 4 mL 4x/dia por 7–14 dias.

6. Antivirais

Herpes simples oral

Aciclovir – 200 mg VO 4/4h (5x/dia), 5 dias.

Valaciclovir – 500 mg VO 12/12h, 5–7 dias.

7. Relaxantes Musculares e Dor Miofascial

DTM, bruxismo, dor muscular

Ciclobenzaprina – 5–10 mg VO à noite, até 10 dias.

Tizanidina – 2–4 mg VO à noite, em casos selecionados.

8. Ansiolíticos (Benzodiazepínicos)

Ansiedade (uso pontual)

Diazepam – 5–10 mg VO à noite, até 3–5 dias.

Lorazepam – 1 mg VO, 1h antes da consulta.

9. Antialérgico

Controle de prurido, reações leves e coadjuvante no edema

Loratadina – 10 mg VO 1x/dia, 5 dias.

Dexclorfeniramina – 2 mg VO 8/8h.

ANOTAÇÕES

03

FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA

Terapia Complementar

10. Terapia Complementar

ENXAGUATÓRIOS / ANTISSÉPTICO

PONTOS-CHAVE

Clorexidina 0,12% – bochecho 15 mL, 2x/dia, até 10 dias.

ESTOMATITE / AFTAS

Triancinolona em orabase – aplicação tópica 2–3x/dia.

Bochecho com dexametasona diluída – em casos selecionados.

XEROSTOMIA (BOCA SECA)

Pilocarpina – 5 mg VO 8/8h (quando indicado).

CONTROLE DE SANGRAMENTO (ANTICOAGULADOS)

Ácido tranexâmico 4,8% – bochecho 10 mL, 4x/dia, até 7 dias.

PROTETORES GÁSTRICOS (associados a AINE/corticoide em pacientes de risco)

Omeprazol – 20 mg VO 1x/dia durante o tratamento.

DOR NEUROPÁTICA

Gabapentina – iniciar com 300 mg VO à noite.

ANOTAÇÕES

04

FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA

Situações Clínicas

11. Situações Clínicas

DOR LEVE

PONTOS-CHAVE

Paracetamol 750 mg 6/6h por 2–3 dias **OU** Dipirona 1 g 6/6h por 2–3 dias.

DOR MODERADA + INFLAMAÇÃO

Ibuprofeno 400 mg 6/6h por até 5 dias **OU** Nimesulida 100 mg 12/12h por até 5 dias.

INFECÇÃO ODONTOGÊNICA AGUDA

Amoxicilina 500 mg 8/8h por 7 dias;

(Se alérgico: Azitromicina 500 mg/dia por 3 dias **OU** Clindamicina 300 mg 8/8h por 7 dias).

PÓS-OPERATÓRIO COM RISCO DE EDEMA

Dexametasona 4 mg 12/12h por 2–3 dias.

CANDIDÍASE ORAL

Fluconazol 150 mg dose única **OU** Nistatina suspensão 4 mL 4x/dia por 7–14 dias.

HERPES LABIAL

Aciclovir 200 mg 4/4h (5x/dia) por 5 dias.

ANOTAÇÕES

05

FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA

Fármacos Mais Utilizados

12. Fármacos Mais Utilizados

Classe	Fármaco	Dose	Intervalo	Duração
Analgésico	Dipirona	1 g VO	6/6h	3 dias
Analgésico	Paracetamol	750 mg–1 g VO	6–8h	máx. 4 g/dia
Analgésico	Ibuprofeno	400 mg VO	6/6h	até 5 dias
Antiinflamatório	Nimesulida	100 mg VO	12/12h	3–5 dias
Antiinflamatório	Dexametasona	4 mg VO	12/12h	2–3 dias
Antibiótico	Amoxicilina	500 mg VO	8/8h	7 dias
Antibiótico	Amoxicilina + Clavulanato	875 mg + 125 mg VO	12/12h	7 dias
Antibiótico	Azitromicina	500 mg VO	1x/dia	3 dias
Antibiótico	Clindamicina	300 mg VO	8/8h	7 dias
Profilaxia	Amoxicilina	2 g VO	Dose única	1h antes
Profilaxia	Clindamicina	600 mg VO	Dose única	1h antes
Antifúngico	Fluconazol	150 mg VO	Dose única	-
Antifúngico	Nistatina	4 mL	4x/dia	7–14 dias
Antiviral	Aciclovir	200 mg VO	4/4h	5 dias
Ansiolítico	Diazepam	5–10 mg VO	à noite	3–5 dias
Antialérgico	Loratadina	10 mg VO	1x/dia	5 dias
Antisséptico	Clorexidina 0,12%	15 mL	2x/dia	até 10 dias

ANOTAÇÕES

06

FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA

Atenção!

13. Atenção!

PONTOS-CHAVE

Gestantes e lactantes: Cuidado especial com antibióticos (tetraciclinas, metronidazol no 1º tri), AINEs no 3º tri e benzodiazepínicos.

Pacientes pediátricos: Ajuste de dose por peso; evitar uso de codeína e alguns relaxantes musculares.

Pacientes idosos: Maior risco de interações medicamentosas, queda e sedação excessiva.

Doenças crônicas: Atenção em hipertensos (AINE), diabéticos (corticoides), hepatopatas (nimesulida, fluconazol, paracetamol em altas doses) e renais (aciclovir, gabapentina).

Histórico de alergia: Sempre questionar sobre alergia a penicilina e derivados.

Boa prática clínica: Prescrever apenas quando necessário, pelo menor tempo possível e sempre orientar o paciente sobre uso correto.

ANOTAÇÕES